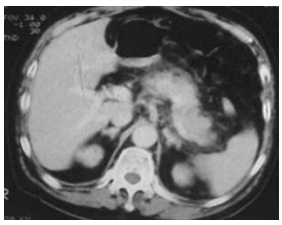
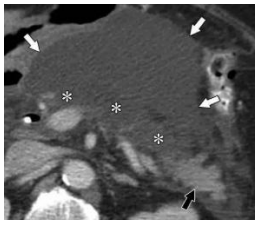
导致胰腺炎最主要原因是胆道疾病,B超在胆道疾病中有优势,可以进一步明确胰腺炎病因,对胰腺炎诊断也有帮助

（二）影像学

（1）B 超：首选影像学

不是最佳:胰腺炎→麻痹性肠梗阻→胃肠道积气→干扰B超

（2）**CT 是最佳影像学**

①明确胰腺炎的**坏死程度**、并发症、决定手术治疗方案的**最佳**检查

②CT 表现：胰腺**增大**、边界**不清**、胰周渗出和液体积聚、胰腺不规则液性低密度区，胰腺呈**不均匀强化**

造影剂排不走

（3）患者有明显肾功能不全时可用 MRI 替代增强 CT。磁共振胰胆管成像 MRCP 对胆管、胰管的**病因搜寻**更有价值　肺栓塞的确诊检查-磁共振肺动脉造影MRPA:可用于严重肾功能不全、碘造影剂过敏、妊娠患者

注意：

细胞坏死→K^+释放→高钾血症　恶心呕吐→低钾血症

①可**升高**的指标：**血/尿淀粉酶、血脂肪酶、腹水淀粉酶和脂肪酶、血钾**（细胞坏死等）、**血糖**（无糖尿病者血糖常＞11.1mmol/L）、**甘油三酯、WBC、C-反应蛋白 CRP、Cr 和 BUN、胆红素和转氨酶、正铁血白蛋白** 反映出血

反映严重程度　应激、感染　肾功能不全　肝功能不全

②可**降低**的指标：**血/尿淀粉酶、血脂肪酶、血钾**（呕吐等）、**血钙**（常＜2mmol/L）、**血氧分压、血白/清蛋白**

ARDS顽固性低氧血症　炎性渗出

早期血糖升高由应激导致　与诊断准确率有关

上述指标多数与预后相关，但：①血糖**后期**与预后有关；②血/尿淀粉酶、血脂肪酶与预后**无关**

表 4-20-2　反映 AP 病理生理变化的实验室检测指标

检测指标	病理生理变化
白细胞↑	炎症或感染
C 反应蛋白＞150mg/L	炎症反应
血糖升高	胰岛素释放减少、胰高血糖素释放增加、胰腺坏死；急性应激反应
TB、AST、ALT↑	胆道梗阻、肝损伤
白蛋白↓	大量炎性渗出、肝损伤
尿素氮、肌酐↑	休克、肾功能不全
血氧分压↓	成人急性呼吸窘迫综合征
血钙＜2mmol/L	Ca^{2+} 内流入腺泡细胞，胰腺坏死
血甘油三酯↑	既可能是 AP 的病因，也可能是急性应激反应所致
血钠、钾、pH 异常	肾功能受损、内环境紊乱

手术造成创伤一加重SIRS一增加死亡率

六、保守治疗为主

（即使重症胰腺炎应尽可能内科及微创治疗）

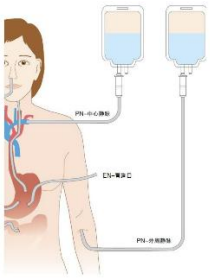
肠道是全身炎症反应的策源地，感染源来自肠道

（一）控制炎症、抑制胰液、维持肠功能

长期肠外营养(无食物刺激肠道)→肠道发生废用性萎缩→肠道屏障功能减退→肠内细菌毒素移位

①**最基本：禁食补液、胃肠减压**　胃、十二指肠都有G细胞→产生胃泌素(全兴奋)→引起胰液分泌

②禁食期行完全肠外营养，待**肠功能恢复**后**尽早肠内营养**（**鼻-空肠管或空肠造瘘**输入）　避开胃、十二指肠



③**谷氨酰胺**保护肠粘膜屏障 小肠上皮细胞能源物质

④**生长抑素或奥曲肽、奥美拉唑或西咪替丁、加贝酯**（抑制胰酶活性）

抑制胰液、止血　抑酸(胃酸是促胰液素最强刺激物,也促缩胆囊素分泌)

急性胰腺炎易发生应激性溃疡从而导致上消化道出血　抑酸预防应激性溃疡

生长抑素或奥曲肽既用于食管胃底静脉曲张引起的消化道出血,也用于胰腺炎

（二）手术指征

①腹腔间隔室综合征 ACS≥25mmHg “2025”

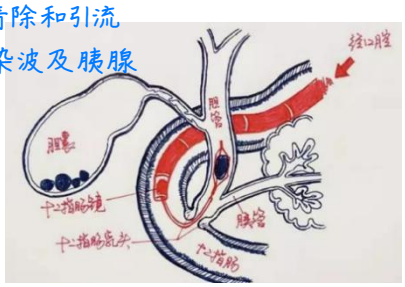
②胰腺和胰周坏死**感染** 降阶梯治疗配合外科进行坏死组织的清除和引流

③胆总管下端**梗阻**（**胆总管扩张＞1cm**）或**胆道感染** 怕胆道感染波及胰腺

若结石嵌顿在胆总管下端致梗阻（不是一过性的渣石头）：

内镜下 Oddi 括约肌切开术 EST+取石术+鼻胆管引流术 ENBD

治疗性ERCP





胆总管做切开取石从胆总管的十二指肠上段入刀

急性胰腺炎的胆管梗阻用治疗性ERCP